INSTRUMENTUL 2 / 5

Hartă de Decizie: Extracție sau Conservare?

În șapte întrebări decide extracția – nu pe baza dintelui, ci a feței, înclinației incisivilor, structurii verticale, parodonțiului și creșterii.

CAPITOLUL 1

Arbore Decizional: 7 Întrebări

Răspunde pe rând; semnele „în favoarea extracției" care se adună în coloana din dreaptă sunt decisive.

1 · Înghesuire: care este necesarul de spațiu per arcadă?

Severă → Necesar mare de spațiu (de obicei peste 7–8 mm): extracția de premolar este un candidat puternic. Celelalte întrebări decid care dinte.

Ușoară–moderată → Mai întâi opțiunile conservatoare: IPR, expansiune, distalizare. Extracție doar dacă și celelalte întrebări o susțin.

2 · Întreabă fața: ce spun profilul și buzele?

Protrusiv → Profil convex, buze pline, protruzate, închidere forțată a buzelor: retracția face bine feței → **în favoarea extracției**.

Drept / concav → Buze subțiri, nas și bărbie pronunțate: retracția poate aplatiza profilul și reduce suportul labial → **în favoarea conservării**.

3 · Înclinația incisivilor: unde se află acum incisivii?

Proclinați → IMPA și U1-SN mult peste valorile normale: nu mai există spațiu pentru a obține loc prin avansarea suplimentară a incisivilor → **în favoarea extracției**.

Verticali / retroclinați → Se poate obține spațiu prin mișcare anterioară controlată (IMPA ~90° referință) → **în favoarea conservării**.

4 · Structură verticală: FMA și overbite?

Unghi mare → FMA peste ~25°, tendință la ocluzie deschisă: mezializarea molarului și controlul vertical susțin extracția, de obicei a al doilea premolar.

Unghi mic → Ocluzie adâncă, musculatură puternică: închiderea spațiului este mai dificilă, ocluzia adâncă se poate accentua → **în favoarea conservării**.

5 · Analiza Bolton: sunt proporționale dimensiunile dentare?

Disproporționate → În excesul inferior, extracție de incisiv inferior sau IPR inferior; la un lateral superior mic, deschide spațiu pentru restaurare. Adaptează șablonul în funcție de aceasta.

Proporționale → Modelele standard de extracție (Capitolul 2) pot fi aplicate; este de așteptat o finalizare simetrică.

6 · Parodonțiu: permit gingia și osul alveolar?

Riscant → Biotip subțire, recesiune, simfiză îngustă; nu împinge incisivii anterior și lateral; expansiunea și proclinația sunt limitate → extracție sau IPR.

Sănătos → Expansiunea limitată și proclinația controlată rămân o opțiune deschisă.

7 · Creștere: în ce etapă se află pacientul?

În creștere → Nu grăbi decizia: RME, aparat funcțional, păstrarea diferenței de dimensiune molar temporar – premolar (spațiul Leeway) cu arc Nance sau lingual poate schimba necesarul de spațiu.

Creștere finalizată → Spațiul poate fi obținut doar pe cale dentoalveolară; la o discrepanță scheletică mare, discută limita de camuflaj și chirurgia ortognată.

Cum să citești

În înghesuirea severă, extracția de premolar este de obicei inevitabilă. În cea ușoară–moderată, numărul de semne „în favoarea extracției" de la întrebările 2–6 decide: dacă nu există niciun semn, nu extenua/extrage; dacă se adună, planifică extracția.

Eroare frecventă

Extragerea în înghesuirea ușoară–moderată bazată doar pe măsurarea pe model. Extracția poate retroclina incisivii, poate aplatiza profilul, poate reduce suportul labial. Decide întotdeauna împreună cu fotografia de profil și cefalometria.

SEMN	ÎN FAVOAREA EXTRACȚIEI	ÎN FAVOAREA CONSERVĂRII
Înghesuire	Severă	Ușoară–moderată
Profil / buză	Convex, buză protrusivă	Drept–concav, buză subțire
Înclinație incisivi	Proclinați	Verticali sau retroclinați
Vertical	Unghi mare, tendință la ocluzie deschisă	Unghi mic, ocluzie adâncă
Parodonțiu	Biotip subțire, alveolă îngustă	Biotip gros, alveolă largă
Creștere	Finalizată, la limita camuflajului	Înaintea sau în timpul puseului de creștere

În cazuri limită, înainte de decizie

- [ ] Fotografia de profil și de zâmbet evaluate una lângă alta
- [ ] Necesarul de spațiu pe arcadă și analiza Bolton calculate
- [ ] IMPA, U1-SN și FMA înregistrate
- [ ] Biotipul gingival și grosimea alveolară a frontalilor inferiori notate
- [ ] Stadiul de creștere determinat (mână-pumn sau vertebră cervicală)
- [ ] Relația finală molară și cerința de ancoraj descrise
- [ ] Opțiunile și limitele lor explicate pacientului

MODULUL 02

Ce Dinte Extrage?

Modelul de extracție determină cerința de ancoraj, gradul de retracție a incisivilor și relația finală molară.

MODEL	CÂND	FII ATENT
4 × 1 premolar	Înghesuire severă, bimaxilară protruzie accentuată; când scopul este deplasarea distală maximă a incisivilor.	Cerință mare de ancoraj; la pacientul cu buze subțiri, retracția excesivă aplatizează profilul.
4 × 2 premolari	Înghesuire moderată, caz limită; profil bun, incisivii trebuie să vină doar puțin mai în spate; la pacientul hiperdivergent, mezializare molară.	La închiderea spațiilor, molarii vin înainte; retracția incisivilor este limitată.
Superior 1 + inferior 2 premolari	În caz cu înclinație spre Clasa II, aducerea relației molare în Clasa I.	Superior, ancorajul trebuie păstrat; inferior, scopul este mezializarea molară.
Superior 2 + inferior 1 premolar	Camuflaj dentar în înclinație ușoară spre Clasa III.	Retracția incisivilor inferiori este limitată de simfiza mentonieră și parodonțiu.
Doar premolarii 1 superiori (2 dinți)	Camuflaj Clasa II: arcadă inferioară ordonată, creștere încheiată; overjetul se închide prin retracție superioară.	Molarii în Clasa II completă, caninii se termină în Clasa I. Nepotrivit în înghesuire inferioară.
Extracție asimetrică	Clasa II unilaterală, discrepanță de linie mediană, dinte absent sau cu pronostic prost pe o parte.	Planifică din timp linia mediană și relația canină; este nevoie de mecanică și ancoraj asimetrice.
Extracție de incisiv inferior	Plus Bolton frontal inferior, înclinație ușoară spre Clasa III, închidere posterioară bună.	Overjetul și overbite-ul pot crește; încearcă mai întâi cu un set-up.
Dinte cu pronostic prost	În caz de molar/premolar cu restaurație mare, tratament endodontic sau lezat, alege-l pe acesta în locul dintelui sănătos.	Mecanica de închidere a spațiilor poate trena; planifică ancorajul și paralelismul radicular.

Eroare frecventă

Să alegi modelul de extracție doar în funcție de înghesuire. Descrie relația finală molară (Clasa I sau Clasa II completă) înainte de extracție; modelul decurge din aceasta.

MODULUL 03

Opțiuni de Conservare și Limitele Lor

Fiecare cale de obținere a spațiului fără extracție are o limită. Un plan care depășește limita provoacă recidivă și problemă parodontală.

OPȚIUNE	CÂND FUNCȚIONEAZĂ	LIMITĂ
IPR (stripping)	Înghesuire ușoară, dinți în formă de triunghi, discrepanță Bolton, risc de triunghi negru.	Grosimea smalțului impune limita; prudență la igienă orală precară și risc crescut de carii. Suprafețele trebuie șlefuite lustruit.
Expansiune maxilară rapidă (RME)	Îngustare transversală osoasă, ocluzie inversă; pacient tânăr cu sutură deschisă.	Efectul osos scade odată cu maturizarea suturii; la adult se ia în considerare soluția cu microșuruburi sau chirurgia ortognată.
Expansiune dentoalveolară	Arcadă îngustă, coridor bucal lat, dinți posteriors înclinați lingual.	Expansiunea regiunii canine nu este stabilă; risc de recesiune gingivală la os bucal subțire.
Distalizare	Necesar mic de spațiu (câțiva mm), relație molară ușoară de Clasa II; mai predictibilă cu ancoraj pe microșurub.	Starea molarului al doilea și al treilea și zona tuberului decide; insuficient la necesar mare de spațiu.
Proclinație controlată	Incisivi retroclinați, profil drept, parodonțiu gros.	Riscant la simfiză îngustă și gingie subțire; protruzia buzelor se accentuează.
Păstrarea spațiului E	Dentație mixtă, molarii temporari încă nu au căzut.	Spațiul se pierde la temporizare ratată; păstrare precoce cu arc Nance sau lingual.

Regulă scurtă

Distalizarea funcționează bine la necesar mic de spațiu. Cu cât necesarul de spațiu este mai mare și buzele sunt mai protruzive, cu atât extracția de premolari este mai predictibilă.

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examenul clinic, decizia medicală și avizul medicului specialist.

Pasul următor

Dacă ai decis privind extracția sau conservarea, pentru detaliile execuției deschide capitolul **Modulul 04 · Gestionarea Spațiului: IPR, Expansiune, Extracții și Ancoraj cu Mini-implanturi**. Pentru clarificarea problemei sagitale, urmează **Instrumentul 3 · Detector Vizual Clasa II vs. Clasa III**.